Orthopädische Klinik König-Ludwig-Haus Würzburg
Ärztl. Direktor: Prof. Dr. med. M. Rudert
Brettreichstr. 11 - 97074 Würzburg - Tel. 0931 803-0 Fax 0931 803-12 09 - info@klh.de - www.koenig-ludwig-haus.de

Bezirk Unterfranken

Julius-Maximilians-UNIVERSITÄT WÜRZBURG
Lehrstuhl für Orthopädie der Universität Würzburg
endoCert
Würzburger EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung am König-Ludwig-Haus

Orthop. Klinik König-Ludwig-Haus · Brettreichstr. 11 · 97074 Würzburg

Frau
Dr. med. Gertrud Overmans
FÄ für Allgemeinmedizin
Jakobsgäßchen 3
91541 Rothenburg ob der Tauber

Würzburg, 07.10.2024

Dr. med. Overmans, Gertrud, geb. 06.01.1980
Paradeisgasse 11, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Diagnose: **Schmerzexazerbation mit V. a. periprothetischer Frühinfekt Hüfte links bei**
- Z. n. Narbenexzision, Wunddébridement und Lavage subkutan/epifaszial am proximalen Oberschenkel links am 2.9.2024 bei Wundheilungsstörung, am ehesten bei Fadengranulom mit Keimnachweis (Staph. aureus) bei
- Z. n. Hüft-TEP Primärimplantation links am 30.7.2020 alio loco (Greifswald); Einliegend: Firma Zimmer Avenir Complete Größe 0, Allofit Pfanne Größe 48, S Keramikkopf
- Z. n. antibiotische Therapie bis 18.9.2024 mit Clindamycin oral

Nebendiagnose:
Z. n. Triple Osteotomie links und rechts mit verstärkter Blutung während der Operation alio loco
Z. n. Arthroskopie Hüfte links 2019
Z. n. rezidivierenden Patellaluxationen rechts, MPFL 2012
Z. n. rezidivierenden Distorsionstraumata der OSG bds.
Hypermobilität der Schultergelenke.
bei hypermobilem Ehlers-Danlos-Syndrom (hEDS)
- **molekulargenetisch Ausschluss einer bekannten, genetisch determinierten EDS-Varianten**
- **Beighton-Score 6 von 9**
- **vorbekannte Hüftdysplasie beidseits, operative Korrektur (Triple-Osteotomie 2016 und 2017)**
- **Z. n. rezidivierender Patellaluxation rechts 1996/2002/2006/2012**
- **MPFL-Ersatz 2012**
- **Nabelhernie, noch offen, nicht operiert**
- **Hypermobilität Schultergelenke ohne Luxation**
- **rezidivierende HWS-Beschwerden**
- **familiäre Prädisposition zur Überbeweglichkeit mütterlicherseits**
- **rezidivierende vasomotorische Symptomatik mit Raynaud-Symptomatik und Hypotonieneigung, sowie Orthostase-Reaktion**

Therapie: **Revision linkes Hüftgelenk mit Débridement, Spülung und Wechsel auf baugleiches Standard PE Inlay für 32 mm Kopf und die 28 mm**

Schwerpunkte:

Endoprothetik Hüfte-Knie | Tumororthopädie
Prof. Dr. M. Rudert
Sekretariat:
Fr. Riedel / Fr. Baumgärtner
Tel.: 0931 803-1101 / 1102
Fax: 0931 803-1109
ortho@klh.de

Kinder-, Wirbelsäulen- u. Neuroorthopädie
Prof. Dr. P. Raab

Fuß u. Sprunggelenkchirurgie
PD Dr. I. Stratos, M.A.

Endoprothetik Hüfte-Knie | Rheumaorthopädie
Dr. A. Jakuscheit

Schulter- u. Ellenbogenchirurgie
PD Dr. K. List

Sekretariat
Fr. Seuling / Fr. Liebetruth
Tel.: 0931 803-1121 / 1123
Fax: 0931 803-1129
michaela.seuling@klh.de
kerstin.liebetruth@klh.de

Sportorthopädie u. Kniegelenkchirurgie
Dr. S. Reppenhagen
Sekretariat: Fr. Neuberger
Tel.: 0931 803-1111
Fax: 0931 803-1119
andrea.neuberger@klh.de

Osteologie | Klinische Studieneinheit
PD Dr. L. Seefried
Sekretariat: Fr. Baumann
Tel.: 0931 803-3590
Fax: 0931 803-1599
jasmin.baumann@klh.de

Terminvereinbarungen:

Privatsprechstunden
Sekretariat Prof. Dr. M. Rudert
und Schwerpunktsekretariate

Poliklinik Sprechstunden
Tel.: 0931 803-1500
Fax: 0931 803-1509
ambulanz@klh.de

CCCMF
Comprehensive Cancer Center Mainfranken

Allofit Pfanne sowie Wechsel des Kopfes auf 32 mm Keramik Option Kopf Firma Zimmer Biomet am 25.09.2024.

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

wir berichten Ihnen über o.g. Patientin, die sich in der Zeit vom 25.09.2024 bis 07.10.2024 in unserem Haus in stationärer Behandlung befand.

Verlauf:
Die stationäre Aufnahme erfolgte notfallmäßig zur Revisionsoperation bei periprothetischer Infektion (DAIR). Extern sei in der Uniklinik Greifswald bereits eine *Staphylococcus aureus* bei operativer Wundrevision nachgewiesen worden.

Parenterale antibiotische Therapie mit Unacid und Vancomycin bis zur Entlassung. Die intraoperativen Abstriche zeigten sich hier negativ (schriftlicher Endbefund zum Zeitpunkt der Entlassung noch ausstehend). Es kam während des stationären Aufenthaltes zu einem Anstieg der Infektparameter mit subjektiven Krankheitsgefühl und Fieber bis 39°C unter laufender antibiotischen Therapie. Dabei präsentierte sich die operierte Extremität klinisch unauffällig. Es kam dann im Verlauf zu einer Besserung der Symptomatik und Rückgang der Infektparameter. Regelrechte Mobilisierung sowie krankengymnastische Beübung.Während des stationären Aufenthaltes erfolgte eine medikamentöse Thromboseprophylaxe mittels Enoxaparin (Clexane®).
Bei Entlassung reizlose Wundverhältnisse ohne Hinweis auf Infekt, TVT oder neurologisches Defizit. Die abschließende Röntgenbildgebung zeigte eine regelrecht einliegende Endoprothese ohne Anhalt für frische Fraktur.

Procedere und Nachbehandlung:
Wir bitten um regelmäßige Wund- und Befund- und Laborkontrollen durch einen niedergelassenen Fachkollegen. Bei resorbierbarem Nahtmaterial ist kein Fadenzug notwendig, die überstehenden Fadenenden können um den 14. postoperativen Tag abgeschnitten werden.

Fortführen der intensiven physiotherapeutischen Beübung entsprechend des angehängten Nachbehandlungsplans.

Antibiotische i.v. Therapie mit Unacid 3 x 2g tgl. bis einschließlich dem 09.10.2024 im ambulanten Bereich. Danach Oralisierung auf Moxifloxacin 1 x 400mg und Rifampicin 2 x 450mg bis zum 06.11.2024.

Fortführung der medikamentösen Thromboseprophylaxe unter regelmäßiger Kontrolle der Thrombozytenzahl im Blutbild (Gefahr einer Heparin-induzierten Thrombozytopenie). Die medikamentöse Thromboseprophylaxe sollte mindestens im Zeitraum von 28 bis 35 Tagen nach der Operation durchgeführt werden.

Reduktion der bedarfsgerechten Schmerztherapie im Verlauf. Bei Dauermedikation mit Metamizol sind regelmäßige Kontrollen des Blutbildes aufgrund der Gefahr einer Agranulozytose angezeigt. Bei Auftreten von Fieber, Halsschmerzen oder entzündlichen Schleimhautveränderungen unter Einnahme von Metamizol umgehende Vorstellung bei einem Arzt.

Wiedervorstellung nur bei Besonderheiten erforderlich. Jährliche Endoprothesenkontrollen beim niedergelassenen Kollegen.

Zum Schutz der implantierten Prothesenkomponenten, sollte bei interkurrenten Infektionen oder ausgedehnten zahnärztlichen Eingriffen eine prophylaktische antibiotische Abschirmung erfolgen.

Labor:

Bezeichnung	Ref.-Bereich	Einheit	26.9.24 06:57	27.9.24 09:59	30.9.24 10:35	4.10.24 09:51	5.10.24 08:57	7.10.24 10:11
CRP-Quantitativ	0.0-0.8	mg/dl	0.2	**2.1↑**	**1.2↑**	**11.1↑**	**11.0↑**	**4.0↑**

Bezeichnung	Ref.-Bereich	Einheit	26.9.24 06:57	27.9.24 09:59	30.9.24 10:35	4.10.24 09:51	5.10.24 08:57	7.10.24 10:11
Leukozyten	4.0-10.0	10^3/µl	6.4	5.4	4.6	**3.4↓**	4.3	4.3
Erythrozyten	3.90-5.60	10^6/µl	**3.56↓**	**3.48↓**	**3.38↓**	**2.81↓**	**3.39↓**	**3.03↓**
Hämoglobin	12.0-16.0	g/dl	**10.0↓**	**9.8↓**	**9.3↓**	*** 7.9↓**	**9.3↓**	**8.2↓**
Hämatokrit	36.0-46.0	%	**30.0↓**	**29.3↓**	**28.2↓**	**23.4↓**	**27.2↓**	**25.2↓**
Mittl. corpusculäres Volumen	80.0-96.0	fl	84.3	84.2	83.4	83.3	80.2	83.2
Mittl. corp. Hb-Gehalt (1 Ery)	27.0-34.0	pg	28.1	28.2	27.5	28.1	27.4	27.1
Mittl. corp. Hb-Gehalt (al. E)	32.0-36.0	g/dl	33.3	33.4	33.0	33.8	34.2	32.5
Erythrozytenverteilungsbreite	11.5-14.5	%	12.9	13.2	13.1	12.8	12.5	13.2
Thrombozyten	140-440	10^3/µl	185	176	153	259	320	359
Mittl. Thrombozytenvolumen	6.5-11.0	fl	10.3	9.9	**11.3↑**	9.7	9.9	9.3
BKS 1h.	<25	mm/h		5		23	**37↑**	
Quick	>70	%	* 71	92	107	83	96	96
Interntional normalized ratio			* 1.26	1.06	0.96	1.13	1.02	1.03
Partielle Thromboplastinzeit	28.0-40.0	sec	* 33.3	39.9	37.5	**46.2↑**	**42.0↑**	**45.5↑**
Fibrinogen	150-450	mg/dl	* 195					
Glucose im Serum	70-110	mg/dl	74	97		**113↑**	99	85
Natrium im Serum	135-150	mmol/l	142	144	144	142	143	144
Kalium im Serum	3.3-5.1	mmol/l	4.0	4.0	4.6	3.6	3.6	4.0
Kalzium im Serum	2.10-2.60	mmol/l	2.37	2.27	2.31	2.11	2.31	2.21
Harnstoff im Serum	1.7-7.5	mmol/l	3.2	2.0	2.1	2.5	**1.2↓**	**1.3↓**
Kreatinin im Serum	45-84	µmol/l	57	53	51	49	47	48
Glomeruläre Filtrationsrate	80-140	ml/min	106	116	121	126	133	130
Harnsäure im Serum	150-350	µmol/l		219		237	255	179
Protein im Serum	60-84	g/l		**57↓**		**54↓**	70	60
Glutamat-Oxalacetat-Transamin.	0-35	U/l		15		12	18	23
Glutamat-Pyruvat-Transaminase	< 34	U/l		7		13	18	20
Gamma-Glutamyl-Transferase	0-39	U/l		17		28	**40↑**	**47↑**
Alkalische Phosphatase	42-98	U/l		57		61	70	65
Vancomycin Talspiegel	>10	µg/ml		*** 3.3↓**	*** 8.2↓**			

Medikation

Ampicillin und Beta-Lactamase-Inhibitoren			
Ampicillin + Sulbactam [Unacid 2000 mg + 1000 mg Plv. z. Inf.]	Intravenös Intermittierend kontinuierlich Infusion	**Dosis Ampicillin : 1 Stk um 06:00, 1 Stk um 14:00, 1 Stk um 22:00, zu verabreichen über 30 min (ergibt 3 Stk/d)** **LÖSUNG 1** Ampicillin + Sulbactam [Unacid 2000 mg + 1000 mg Plv. z. Inf.] : **1 Stk, 6,4 ml** Isot. Kochsalzlsg. NaCl 0,9 % 100 ml Inf. : **100 ml** Volumen : 106,4 ml Konzentration : 0,0094 Stk/ml **ZU VERABREICHENDE ZUSAMMENSETZUNG** LÖSUNG 1 : **106,4 ml** Flussrate : **212,8 ml/h** Dauer der Zusammensetzung : 30 min	01.10.2024 bis inkl. 09.10.2024
Diclofenac			
Diclofenac [Voltaren Resinat 75 mg Retard-Kps.]	Oral	**1 - 0 - 1 Stk**	
Enoxaparin			
Enoxaparin 40 mg/0,4 ml Fsp.	Subkutan	**1 Stk um 07:00**	
Moxifloxacin			
Moxifloxacin AL 400 mg Filmtabletten	Oral	**1 - 0 - 0 Stk**	10.10.2024 bis inkl. 06.11.2024
Pantoprazol			
Pantoprazol 20 mg magensaftr. Tbl.	Oral	**1 - 0 - 0 Stk**	
Rifampicin			
Rifampicin [Eremfat 450 mg Tbl.]	Oral	**1 - 0 - 1 Stk**	10.10.2024 bis inkl. 06.11.2024

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. med. M. Lüdemann
Oberarzt
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin

L. Wiederhold
Assistenzärztin